

ITEM 257 : HÉMATURIE UROLOGIQUE

Hématurie = quantité anormale d'hématies dans les urines lors d'une miction ($> 10/\text{mm}^3$ ou $10^4 = 10\,000/\text{mL}$)

- **Cause urologique** : lésion du parenchyme rénal ou de l'arbre urinaire, conduisant à l'effraction de vaisseaux sanguins
- **Cause néphrologique = glomérulaire** : passage des hématies à travers une membrane basale glomérulaire altérée
- **Hématurie idiopathique/essentielle** dans $> 10\%$ des cas : sans cause retrouvée après bilan urinaire complet

Diagnostic	= Coloration rouge des urines, BU positive (à partir de > 5 hématies/mm³), confirmé par le sédiment urinaire (ECBU) - Hématurie macroscopique : coloration rosée, rouge ou brunâtre visible à l'œil, > 500 hématies/mm³ - Hématurie microscopique : invisible, découverte à la BU/ECBU, > 10 hématies/mm³ → Une hématurie macroscopique ou microscopique ont la même valeur sémiologique		
	DD	- Hémorragie de voisinage : urétrorragie, menstruation, métrorragie, hémospémie - Cause métabolique : myoglobinurie (rhabdomyolyse), hémoglobinurie (hémolyse), uribilinurie, porphyrie - Cause alimentaire : betteraves, mûres, myrtilles, rhubarbe, chou rouge, colorant alimentaire - Médicament : rifampicine, érythromycine, métronidazole, acide aminosalicylique, salazopyrine, ibuprofène, vitamine B12, laxatifs contenant de la pénolphtaléine, contact avec un antiseptique (povidone iodé, Dakin®) - Intoxication au plomb ou au mercure → La BU est aussi positive en cas de myoglobinurie ou d'hémoglobinurie : diagnostic différentiel à l'ECBU	
Stratégie diagnostique	Int	- Origine ethnique, voyage en zone d'endémie : bilharziose - Exposition professionnelle (amine aromatique, goudron, colorant), tabagisme, traitement par cyclophosphamide, irradiation pelvienne : FdR de cancer urothélial - Insuffisance rénale ou surdit� héréditaire : syndrome d'Alport - Autres : atcds familiaux (PKRAD), traumatisme, chirurgie, prise d'anticoagulant (révélateur), AINS	
	C		- Orientation urologique : présence de caillot, SFU associés (pollakiurie, dysurie, brûlure mictionnelle), fièvre, colique néphrétique, douleur lombaire spontanée ou à la palpation - Orientation néphrologique : HTA, œd�me, insuffisance rénale - Autres : varicoc�le (tumeur rénale gauche), touchers pelviens (HPB, cancers prostatiques, masse pelvienne)
		Chronologie	Initiale = origine ur�tro-prostatique Terminale = origine v�sicale Totale = origine r�nale → Sans valeur localisatrice en cas d'h�maturie abondante
		Gravit�	- Retentissement h�modynamique : hypovol�mie - Hypertension maligne - Globe v�sical : r�tention urinaire aigu� sur caillottage - An�mie
	Bio	- ECBU : - Confirmation diagnostic + analyse bact�riologique ± recherche bilharziose si contexte - Pr�sence de cylindres h�matiques ou d'h�maties d�form�es : en faveur d'une origine n�phrologique - Prot�inurie/24h : origine n�phrologique si > 2 g/24h (possiblement li� à l'h�maturie jusqu'� 1 g/24h) - Retentissement de l'h�maturie : NFS, h�mostase, bilan r�nale - Cytologie urinaire (sur urines du matin ou pr�l�vement endoscopique) : d�tection de cellules tumorales de haut grade (Se > 90%), faible sensibilit� pour les tumeurs de bas grade → ne dispense pas d'une endoscopie si n�gative	
	PC	Echo v�sico-r�nale	= En 1�re intention : - Tumeur du parenchyme r�nal, des cavit�s py�localicielles ou v�sicale - Lithiase, kystes r�naux - Signes indirects : ur�t�ro-hydron�phrose, caillottage... - Doppler : recherche de thrombose des veines r�nales
		Uroscanner	= Examen de r�f�rence : d'�mbl�e ou si �chographie n�gative ou n�cessit� de compl�ment - Recherche de tumeurs, calcul de petite taille, anomalie des vaisseaux r�naux... - Uro-IRM si contre-indication au scanner
Cystoscopie		- Indication : - > 50 ans ou FdR de tumeur uroth�liale : recherche de cancer v�sical - Suspicion de cause sous-v�sicale (h�maturie initiale) : �tude de la fili�re ur�trale - Ejaculat ur�trale d'urine sanglante aux m�ats ur�t�raux : en faveur d'une origine urologique si unilat�ral ou n�phrologique si bilat�ral	
- PBR : � discuter si origine n�phrologique (prot�inurie glom�rulaire, HTA) - ASP : souvent r�alis� en urgence en cas de colique n�phr�tique, non indiqu� en cas d'h�maturie isol�e - Ur�t�roscopie (au bloc, sous AG) : en cas de suspicion de tumeur ur�trale ou py�localiciale, ou de FdR de tumeur uroth�liale avec un bilan morphologique et cystoscopique n�gatif - Art�riographie : seulement en cas de forte suspicion d'atteinte vasculaire, notamment lors d'un traumatisme r�nal, � la recherche d'un saignement actif n�cessitant une embolisation			

Etiologie	Urologique	Tumeur urothéliale	= Tumeur vésicale ou des voies excrétrices supérieures : 12 000 cas/an en France - Bilan : cystoscopie et uroscanner ± cytologie	
		Tumeur rénale	= Tumeur maligne (ADK...) ou bénigne (angiomyolipome...) : 12 000 cas/an en France - Hématurie macroscopique totale, intermittente, silencieuse - Douleur lombaire chronique - Bilan : échographie ou TDM abdomino-pelvien injecté	
		Infection urinaire	= Cause la plus fréquente d'hématurie : - Cystite, pyélonéphrite, prostatite : tableau clinique évocateur, hématurie généralement macroscopique si cystite ou microscopique si PNA, diagnostic par BU/ECBU - Bilharziose : zone d'endémie (Afrique du Nord, péninsule arabique), hyperéosinophilie → diagnostic sur examen direct des urines 3 jours de suite (recherche d'œufs) ou sur prélèvement endoscopique de muqueuse vésicale ± rectale (meilleure sensibilité) - Tuberculose urinaire : immunodépression, localisation pulmonaire, leucocyturie aseptique, calcifications des parois vésicales ou urétérales (aspect de « vessie porcelaine »)	
		Lithiase urinaire	- Hématurie le plus souvent microscopique - Pauci-symptomatique ou révélé par un épisode de colique néphrétique - Bilan : scanner abdomino-pelvien en phase douloureuse, uroscanner hors phase aiguë	
		Traumatisme	- Lésion possible : fracture du parenchyme rénal, atteinte du pédicule vasculaire, plaie vésicale - Bilan : uroscanner ± angiographie si patient stable, échographie si patient instable	
		Prostatique	= Généralement hématurie macroscopique initiale : diagnostic d'élimination - HBP ou prostatite , plus rarement cancer prostatique	
		Iatrogène	- Geste urologique : sondage, cathéter sus-pubien, résection endoscopique, lithotritie, PBR - Cystite radique - Post-chirurgical	
	Néphrologique	Néphropathie vasculaire	Nécrose papillaire	- Contexte : diabète, drépanocytose, AINS - Tableau de colique néphrétique (migration de fragment papillaire dans l'uretère) ± Hyperthermie, insuffisance rénale - Uroscanner : amputation calicelle, absence de lithiase
			Infarctus rénal	- Contexte : post-traumatique, drépanocytose, maladie thromboembolique (AC/FA...) - Hématurie avec douleur lombaire brutale , difficilement calmée par les antalgiques - Scanner abdomino-pelvien injecté, angio-IRM ou écho-Doppler : image d'infarctus rénal - PEC urgente (dans les 6h) : reperméabilisation de l'artère rénale par voie radio-interventionnelle (stent) ou chirurgical (thrombectomie)
			Hématurie d'effort	= Après une activité physique prolongée : microtraumatismes rénaux ou vésicaux et perméabilité glomérulaire accrue pendant l'effort - Généralement hématurie microscopique (80% des cas), disparaissant après quelques jours de repos
TTT	CAT en urgence	= En cas d'hématurie macroscopique avec caillottage et/ou rétention aiguë d'urine - Sonde vésicale double courant avec mesures d'asepsies, en système clos (+ ECBU lors de la pose) - Irrigations/lavages en continu ± décaillotages à la seringue si nécessaire → Contre-indication au cathéter sus-pubien : risque de dissémination d'un possible cancer vésical		
	Hors urgence	= En cas d'hématurie macroscopique asymptomatique - Hydratation orale abondante pour diluer l'hématurie et éviter le risque de caillottage, et faciliter la coagulation de la lésion à l'origine de l'hématurie		